

KC桌面——外资精译

GS：中国医疗健康，ESMO2026中国数据点-关注sac

2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于10月23-27日在马德里举行，目前已公布常规摘要标题。我们总结了中国制药/生物技术公司中值得关注的资产和数据点，并重点介绍PD-1多特异性抗体、靶向DLL3的疗法（由再鼎医药的ZL-1310领衔）、不断演变的ADC格局以及新兴的RAS抑制剂。最新突破摘要（LBA）标题将于9月25日公布，完整摘要将于欧洲中部时间10月19日00:05发布，届时将提供详细数据。

在科伦博泰宣布中国III期OptiTROP-Lung06试验（1L nsq-NSCLC，PD-L1 TPS<1%）已达到主要终点（PFS）后，市场对潜在以LBA形式在ESMO上发布详细数据的预期正在升温（参见我们的报告）。虽然LBA提交仍在进行中（截止日期为9月8日），我们等待9月25日标题的最终发布，并预计如果Lung06数据确认参会，它将成为最受关注的焦点之一。我们还看到ADC的前景日益广阔，取得了显著的临床成果，包括：1) ADC联合数据：SHR-1826（cMET ADC，恒瑞医药）联合PD-L1和CTLA-4抑制剂治疗2L+ nsqNSCLC的II期数据，以及SHR-A1904（CLDN18.2 ADC，恒瑞医药）联合阿得贝利单抗（±化疗）治疗1L GC/GEJC的I期数据将发布，而我们的关注点将在于其兼容性——联合用药对治疗特征的影响，特别是重叠毒性与带来的增量获益之间的平衡；以及2) 新型ADC临床数据首秀：靶向EGFR/c-MET的双特异性ADC（HS-20122，翰森制药）和一种新的CDH17 ADC（CM518D1，科济药业）将在实体瘤中公布初步的I期数据，我们关注该模式下的差异化趋势。

SCLC中的DLL3疗法，关注一线zoci：针对SCLC的DLL3靶向疗法的新临床进展将在大会上公布，包括：1) zoci（ZL-1310，DLL3 ADC，再鼎医药）联合阿替利珠单抗±卡铂治疗1L SCLC的Ib/Ic期结果。我们注意到，作为再鼎医药2026年下半年的关键催化剂，鉴于在2L治疗中竞争疗法的疗效大致相当，该数据对于zoci凭借其良好的安全性特征深化其在SCLC领域的差异化至关重要；2) alveltamig（DLL3/DLL3/CD3 TsTCE，泽璟制药）单药治疗2L+ SCLC的I期研究更新了延长随访后的总生存期（OS）数据。回顾一下，alveltamig在ASCO数据读出中显示了58.6%的18个月OS率，暗示中位OS可能达到20-25个月，本次数据将予以确认。该结果可与tarlatamab来自其III期DeLLphi-304研究的最新2L OS更新数据进行比较，后者也将在大会上发布（此前报告为GS (Asia) L.L.C. GS (Asia) L.L.C. GS (Asia) L.L.C. GS (Asia) L.L.C. 13.6个月）。我们认为这一比较是衡量alveltamig在SCLC竞争中定位的基准；3) 恒瑞医药DLL3 ADC（SHR-4849）治疗2L+ SCLC的长期I期生存数据更新，以及来自DLL3 TCE（SHR-7787）的首个I/II期数据；4) 可能从翰森制药HS-20093（B7H3 ADC）治疗2L SCLC的进行中试验（TiP）摘要中窥见其早期III期数据，这可能在初步II期数据之外进一步验证B7H3类药物对2L SCLC的疗效，并提供更好的2L治疗格局可见性。除DLL3外，SKB500（B7H3 ADC，科伦博泰）也将公布治疗2L+ SCLC的疗效和安全性更新数据。

PD-1多特异性抗体的增量更新：今年的ESMO展示了不断发展的多特异性抗体格局，临床数据日趋成熟。我们重点关注：1) 依沃西单抗（PD-1/VEGF双抗，康方生物）作为一线疗法治疗一系列实体瘤（肾细胞癌、胸腺癌、食管鳞状细胞癌和子宫内膜癌），以及一项关于NSCLC脑转移患者颅内PFS的亚组研究；2) 基石药业三特异性抗体CS2009（PD-1/VEGF/CTLA-4三抗）治疗晚期NSCLC的II期剂量扩展数据，以及治疗mCRC的I/II期数据，这是对ASCO 2026公布的初步数据的更新。我们认为这些增量数据对于计划于2026年底启动的III期MRCT至关重要；3) 信达生物IBI363（PD-1/IL-2α 偏向型双抗）的更新数据，包括联合化疗治疗1L NSCLC，以及与多西他赛头对头

联合贝伐珠单抗治疗IO耐药AGA(-)NSCLC，以及治疗1L胃或胃食管交界处腺癌的I期试验首次数据读出。我们关注1L NSCLC的特殊给药方案，以及在IO治疗过的鳞状NSCLC中差异化的长尾获益，正如ASCO更新中所展示的那样；4) pumitamig (PD-L1/VEGF-A双抗, BioNTech) 治疗神经内分泌肿瘤、SCLC或伴脑转移的TNBC的II期数据读出；以及5) PD-L1/VEGF双抗 (pumitamig, BioNTech) 与ADC (DB-1311, B7-H3 ADC, Duality/BioNTech) 联合治疗实体瘤的首个全球II期数据。

针对RAS突变的新兴靶向疗法：针对RAS突变的疗法日益受到关注，尤其是在Revolution Medicines (RevMed) 今年早些时候宣布其panRAS抑制剂daraxonrasib在2L+ PDAC中的III期RASolute302研究取得了设定标杆的结果之后。在ESMO上，我们看到一系列RAS/KRAS抑制剂将展示最新数据，包括：1) KRAS G12D抑制剂：HRS-4642 (恒瑞医药)、INCB161734 (Incyte) 和GFH375 (劲方医药，据公司称将作为LBA) 都将在携带KRAS G12D突变的PDAC中公布I/II期数据，这些数据可与zoldonrasib (KRAS G12D抑制剂, RevMed) 在ESMO GI上发布的数据进行交叉比较；以及2) panRAS分子胶：劲方医药的GFH276将作为LBA (据公司称) 公布其在实体瘤中的首个I期数据。

图表1：ESMO 2026上来自中国制药/生物技术公司的摘要信息

图表2：ESMO 2026上来自中国制药/生物技术公司的摘要信息（续）

附录披露：公司情况更新

Reg AC

我们，Ziyi Chen,Linhai Zhao,Ph.D.,Honglin Yan 和 Eddie Song，特此证明本报告中表达的所有观点均准确反映了我们个人对相关公司或其标的的看法。我们还证明，我们的薪酬中没有任何部分直接或间接地与报告中表达的具体建议或观点相关。

撰稿作者：Ziyi Chen GS (Asia) L.L.C.,Linhai Zhao,Ph.D. GS (Asia) L.L.C.,Honglin Yan GS (Asia) L.L.C.,Eddie Song GS (Asia) L.L.C..

GS因子概况

GS因子概况通过将公司的关键属性与市场（即我们的评级公司池）及其行业同行进行比较，为公司提供研究背景。所描绘的四个关键属性是：增长、财务回报、倍数（例如估值）和综合（增长、财务回报和倍数的组合）。增长、财务回报和倍数是通过使用每只公司特定指标的标准化排名计算得出的。然后将这些指标的标准化排名进行平均，并转换为相应属性的百分位数。每个指标的具体计算可能因财年、行业和地区而异，但标准方法如下

增长基于公司的前瞻性销售增长、EBITDA增长和EPS增长（对于资金股，仅EPS和销售增长），百分位数越高表示公司增长越快。财务回报基于公司的前瞻性ROE、ROCE和CROCI（对于资金股，仅ROE），百分位数越高表示公司财务回报越高。倍数基于公司的前瞻性市盈率（P/E）、市净率（P/B）、报价/股息（P/D）、EV/EBITDA、EV/FCF和EV/债务调整后现金流（DACF）（对于资金股，仅P/E、P/B和P/D），百分位数越高表示公司交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100% - 倍数百分位数）的平均值。

财务回报和倍数使用GS分析师对未来至少三个季度后的财年末的预测。增长使用对未来至少七个季度后的财年与至少三个季度后的财年相比的输入数据（所有指标均基于每股）。

有关我们如何计算GS因子概况的更详细描述，请联系您的GS代表。

并购排名：公司情况更新

在我们的全球覆盖范围内，我们使用并购框架审视公司，同时考虑定性因素和定量因素（这些因素可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的潜力。然后，我们分配一个并购排名，作为对我们评级覆盖范围内的公司进行评分的方法，从1到3，其中1表示公司成为收购目标的可能性高（30%-50%），2表示可能性中等（15%-30%），3表示可能性低（0%-15%）。对于排名为1或2的公司，根据我们的标准部门指南。并购排名为3

被视为不重要，并且可能在研究报告中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum是GS的专有数据库，提供详细的财务报表历史、预测和比率访问。它可用于对单一公司进行深入分析，或比较不同行业和市场公司。